

11 - 05- Rétrécissement mitral - Pr. El Karimi

(0:00 - 1:45)

Bonjour chers étudiants, nous allons voir aujourd'hui le rétrécissement mitral, l'une des valvulopathies les plus fréquentes et dont l'étiologie principale dans notre contexte reste la cause rhumatismale. Au terme de ce cours, nous devons être capables de définir le rétrécissement mitral, d'expliquer son mécanisme physiopathologique, de décrire les caractéristiques des signes fonctionnels et physiques en faveur d'un rétrécissement mitral chez un patient suivi pour un cardit rhumatismal chronique. On doit être capables aussi de décrire les résultats des examens paracliniques chez un patient suivi pour rétrécissement mitral serré.

On doit être capables aussi d'énumérer les complications pouvant survenir chez ces patients, d'énumérer les éventualités thérapeutiques curatives pouvant être proposées chez ces patients, et enfin de prescrire le protocole de prévention de l'endocardite infectieuse chez un patient suivi pour cette pathologie. Pour aboutir à ces objectifs, nous allons suivre le plan suivant. D'abord une introduction au cours de laquelle on va voir ce qu'est le rétrécissement mitral ainsi que l'intérêt de la question.

Après on va voir un petit rappel anatomo-physiologique avant de s'étaler sur le mécanisme physiopathologique ainsi que les conséquences du rétrécissement mitral. Par la suite, nous allons voir les étiologies puis on va s'étaler sur le diagnostic positif. Ensuite, nous allons voir l'évolution et complications de cette maladie, certaines formes cliniques, avant de terminer par le traitement et la conclusion.

(1:47 - 4:21)

C'est quoi le rétrécissement mitral? C'est la réduction de la surface mitrale. On sait bien que la surface mitrale normale est de l'ordre de 4 à 6 cm². Donc quand cette surface est réduite, elle constitue un barrage au remplissage du ventricule gauche et ceci au cours de la diastole, parce qu'au moment de la systole la valve est normalement fermée.

Donc le problème se pose au moment de la diastole où la valve doit s'ouvrir complètement pour assurer le remplissage du ventricule gauche. Donc quand on a un rétrécissement mitral, il se crée un barrage au remplissage du ventricule gauche. Ceci devient parlant quand on a une surface inférieure à 2 cm².

Donc il faut savoir que c'est une valvulopathie fréquente, pratiquement la plus fréquente des valvulopathies. Ses conséquences peuvent être graves comme on va le voir dans le chapitre des complications et que dans notre contexte, le rhumatisme articulaire aigu reste la cause la plus fréquente, ce qui souligne l'intérêt de la prévention avant d'arriver à ces complications. Sur le plan anatomique et physiologique, le cœur est constitué de deux côtés, le côté gauche et le côté droit.

Le côté gauche est constitué de l'oreillette gauche et du ventricule gauche et le côté droit de l'oreillette droite et du ventricule droit. L'oreillette gauche et le ventricule gauche sont séparés par la valve mitrale et le ventricule gauche donne issue à l'aorte qui va assurer l'éjection vers la périphérie. Du côté droit, nous avons l'oreillette droite qui sépare le ventricule droit par la valve tricuspide.

Le ventricule droit assure l'éjection du sang vers la circulation pulmonaire à travers l'artère pulmonaire. Concernant l'anatomie de la valve mitrale, et contrairement à ce que l'on croit, la valve mitrale n'est pas constituée uniquement des deux feuillets antérieurs et postérieurs mais c'est un vrai appareil dont chaque structure participe dans l'étanchéité et dans l'ouverture de la valve mitrale. Comme vous le voyez sur le schéma de votre droite, l'appareil mitral est constitué d'un anneau qui entoure la valve mitrale ou ses feuillets.

(4:22 - 5:02)

Il est constitué de deux valves mitrales antérieures et postérieures, de cordage et des muscles papillaires qui se reposent sur le myocarde sous-jacent. Quand vous le voyez sur votre schéma situé de votre côté gauche, nous trouvons au niveau de la valve mitrale, la valve mitrale antérieure et la valve mitrale postérieure. On a l'impression que la valve mitrale postérieure est plus petite que la valve mitrale antérieure, mais c'est pas vrai ils ont à peu près la même surface, sauf que la valve mitrale antérieure est plus large et la valve mitrale postérieure est plus longue.

(5:04 - 5:22)

Ces deux valves sont séparées sur leurs bords par ce qu'on appelle les commissures. Donc nous avons la commissure postéro-interne et la commissure antéro-externe. L'ensemble de ces deux feuillets sont entourés par l'anneau mitral comme on l'a vu tout à l'heure.

(5:24 - 6:04)

Pour pouvoir comprendre la physiopathologie un petit rappel sur la physiologie, c'est-à-dire le cycle cardiaque est nécessaire. Donc le son veineux oxygéné qui vient du poumon va rejoindre l'oreillette gauche puis le ventricule gauche à travers la valve mitrale après il va rejoindre la circulation systémique à partir de l'aorte. A partir de l'aorte, le son oxygéné va rejoindre les différents organes comme le cerveau les muscles, les reins où ce son va être pris par ces organes et avec libération du CO₂.

(6:05 - 6:30)

Donc le son désoxygéné libéré à partir de ces organes va rejoindre le cœur à travers la veine inférieure et supérieure. Ainsi il va rejoindre les poumons à travers l'artère pulmonaire. On arrive maintenant à la physiopathologie du rétrécissement mitral et on va commencer par le mécanisme.

(6:31 - 11:08)

Donc le mécanisme principal c'est une réduction de la surface donc c'est un rétrécissement mitral. Donc c'est la réduction de la surface de la valve mitrale. Cette réduction de la surface mitrale peut être due à plusieurs mécanismes.

D'abord en ce qui concerne les séquelles du rhumatisme articulaire aigu, ça peut être une soudure des commissures, c'est à dire des commissures qui fusionnent ça peut être une sclérose ou calcification de la valve ça peut être aussi un épaissement avec fusion et raccourcissement des cordages. Le mécanisme dans les cardiopathies congénitales est encore plus complexe, on ne va pas l'aborder dans ce chapitre. Quelles sont maintenant les conséquences de cette réduction de la surface mitrale? Donc il faut savoir que ces conséquences peuvent être d'ordre hémodynamique ou bien d'ordre infectieuse.

Les conséquences hémodynamiques ne se voient que dans les formes serrées alors que les conséquences infectieuses sous forme d'endocardites infectieuses se voient indépendamment de la sévérité du rétrécissement et il faut noter que les valvulopathies sténosantes sont moins pourvoyeuses d'endocardites infectieuses par rapport aux valvulopathies fuyantes. D'une manière générale, ces conséquences hémodynamiques se font sur plusieurs mois voire plusieurs années. Pourquoi? Parce que pour que ce rétrécissement mitral s'installe et devienne serré il nous faut beaucoup de temps, c'est un processus qui évolue dans le temps et d'une manière simple, ces conséquences peuvent être divisées en deux parties.

Conséquences en amont de la valve mitrale et les conséquences en aval. Les conséquences en amont, c'est-à-dire tout ce qui survient au-dessus de la valve mitrale donc ça va concerner l'oreillette gauche, les veines pulmonaires, les capillaires pulmonaires et les poumons bien évidemment les artères et les artérioles pulmonaires puis les cavités droites. En ce qui concerne les conséquences en aval c'est tout ce qui survient en aval, c'est-à-dire après la valve mitrale donc c'est le ventricule gauche et la circulation systémique. On va voir maintenant les conséquences en amont et on va commencer par l'oreillette gauche. Donc comme vous le voyez sur ce schéma le rétrécissement mitral constitue un obstacle au passage du son de l'oreillette gauche vers le ventricule gauche au moment de la diastole donc ceci va générer une augmentation de la pression au niveau de l'oreillette gauche.

Cette augmentation de la pression intra-oreillette gauche va être responsable d'une dilatation progressive de cette dernière comme mécanisme de compensation, c'est-à-dire l'oreillette gauche va tendre à baisser cette pression intra-og via la dilatation. Ceci va avoir deux types de conséquences. D'abord des modifications en ce qui concerne la structure des fibres auriculaires gauche, ce qui va générer des troubles de rythme, surtout la fibre il y a son auriculaire qui va se traduire sur le plan clinique par des palpitations. De l'autre côté, cette dilatation de l'oreillette gauche va créer une sorte de stase du son.

Et qui dit stase dit possibilité de constitution de thrombus. Le thrombus une fois constitué, il peut migrer et il va être responsable d'embolies. Au niveau du cerveau, on aura un accident

vasculaire cérébral ischémique aigu.

On peut voir aussi une embolie vers les membres inférieurs et on aura une ischémie aiguë des membres inférieurs. L'embolie peut se faire aussi dans d'autres endroits moins rares comme infarctus intestinal, infarctus plénique, ainsi de suite. On arrive maintenant aux conséquences au niveau des veines, capillaires pulmonaires et au niveau du poumon.

On a vu tout à l'heure que le rétrécissement mitral va constituer un barrage au remplissage du ventricule et ceci va donner une augmentation de la pression intra-ongée. Hormis les conséquences qui surviennent au niveau de l'oreillette gauche elle-même, cette augmentation de la pression va être transmise aussi aux veines pulmonaires. Donc on aura une augmentation de la pression veineuse pulmonaire appelée hypertension pulmonaire postcapillaire.

(11:10 - 11:54)

Elle est passive. Donc cette pression est passive et réversible sous traitement. Cette augmentation de la pression au niveau des veines pulmonaires va être transmise par la suite aux capillaires.

Quand la pression au niveau des capillaires, cette pression hydrostatique, va dépasser la pression oncotique, c'est à dire quand elle est supérieure à 35 mm de mercure, il y aura un passage du liquide vers le milieu interstitiel voire le milieu alvéolaire. Ce qui va nous donner soit un tableau d'insuffisance cardiaque gauche soit carrément un œdème aigu du poumon. Donc l'insuffisance cardiaque gauche va se traduire par la dyspnée et l'œdème aigu du poumon peut se traduire par l'orthopnée.

(11:55 - 12:36)

Il faut noter aussi que la dyspnée peut survenir aussi à travers l'hypertension pulmonaire postcapillaire. Cette pression va être transmise bien évidemment vers les artères et les artérioles pulmonaires ainsi que vers les cavités droites. Donc cette pression au niveau des capillaires pulmonaires, hormis ses conséquences sur les poumons, c'est à dire vers le milieu interstitiel et alvéolaire, il y aura une transmission de cette pression aussi vers les artères et les artérioles pulmonaires et on aura ce qu'on appelle l'hypertension pulmonaire précapillaire et c'est une hypertension active, laquelle va être responsable aussi de dyspnée.

(12:37 - 14:46)

Cette augmentation de la pression au niveau des artères et les artérioles pulmonaires va constituer une sorte d'obstacle, va augmenter la postcharge des ventricules et les cavités droites. Donc le ventricule droit va essayer ou doit fournir plus d'efforts pour éjecter vers les artères pulmonaires. Donc c'est un obstacle à l'éjection du VD.

Donc ce ventricule droit va finir par lâcher, il va se dilater et on aura des signes d'insuffisance cardiaque droite qui vont se traduire par des œdèmes des membres inférieurs et pathologies

d'effort et Arsère, comme vous allez le voir en détail dans le cours de l'insuffisance cardiaque. Donc on a fini par les conséquences en amont, qui sont l'oreillette gauche, les veines pulmonaires, les capillaires avec le milieu interstitiel du poumon et alvéolaire et ensuite les artères, artérioles pulmonaires et la cavité droite. Maintenant on va voir les conséquences en aval.

Ca va toucher spécialement la circulation systémique parce que le rétrécissement mitral va limiter le passage du sang vers le ventricule gauche et donc le ventricule gauche va être vraiment au repos, il va devenir petit et tranquille. Par contre on va assister à une diminution du débit systémique. Cette diminution du débit systémique va être compensée au début par les moyens de compensation que vous allez voir dans le cours de l'insuffisance cardiaque, mais à un certain moment ils vont être dépassés et on va assister à un amégrissement, un retard staturopondéral et des signes de bas débit cardiaque à un stade vraiment évolué.

Donc ce que vous devez retenir du mécanisme physiopathologique du rétrécissement mitral, c'est qu'on a des conséquences en amont et des conséquences en aval. Pour les conséquences en amont, on commence par l'oreillette gauche, il s'agit d'une dilatation de cette cavité avec fibrillation auriculaire et thrombus. On a des signes d'insuffisance cardiaque gauche ou bien DOAP.

(14:47 - 17:53)

On a de l'hypertension pulmonaire, précapillaire et postcapillaire. Et enfin on a des dilatations des cavités droites avec des signes d'insuffisance cardiaque droite. En ce qui concerne les conséquences en aval, on va avoir une diminution du débit cardiaque qui va se traduire par un amégrissement, un retard staturopondéral et un état de bas débit cardiaque quand les mécanismes d'adaptation vont être dépassés.

Quelles sont maintenant les étiologies du rétrécissement mitral? Comme on l'a vu dans l'introduction, deux étiologies principales. D'abord la maladie rhumatismale, elle constitue la cause la plus fréquente et en deuxième position on trouve la cause congénitale. Comment faire maintenant le diagnostic du rétrécissement mitral? On va commencer par les circonstances des découvertes et ça peut être d'une manière fortuite par la découverte d'un souffle pour une consultation pour une autre raison ou bien dans les campagnes de dépistage qui se font au niveau des écoles ou bien dans les milieux de travail.

Le diagnostic peut se faire lors d'un suivi d'un patient ayant un antécédent de RAA ou bien pour les cardiopathies congénitales lors d'un suivi d'une grossesse. La découverte peut se faire lors de l'apparition des symptômes ou bien carrément des complications. En ce qui concerne le motif de consultation, donc quand le patient est symptomatique, la plupart du temps il s'agit d'une dyspnée, ça peut être une fatigabilité ou bien des palpitations.

Il faut être vraiment attentif en matière de l'interrogatoire parce que dans notre contexte et dans notre langue, c'est-à-dire arabe dialectal, il y a des expressions qui peuvent simuler

plusieurs signes sémiologiques, par exemple ça peut faire allusion à la fatigue, perte de connaissance, dyspnée, voire d'autres. Donc il faut faire attention, être attentif pour mettre le point sur le signe sémiologique exact que rapporte le patient. Un malade qui vient pour un signe ou une symptomatologie il faut décrire ses caractéristiques et comme on l'a dit tout à l'heure, le motif le plus important c'est la dyspnée ça peut être parfois des palpitations, des signes d'insuffisance cardiaque droite ou bien carrément une hémoptysie à l'effort quand le patient a une hypertension pulmonaire assez sévère.

Donc la deuxième étape de l'interrogatoire va permettre de chercher les antécédents qui sont en général orientés par le symptôme. Donc il faut poser la question concernant les antécédents de maladie rhumatismale. Est-ce qu'il a un antécédent de RAA? Parfois ce n'est pas une maladie qui a été déclarée mais c'est juste des arthragies ou bien des arthritides dans l'enfance pour lesquelles le patient n'a pas consulté.

(17:54 - 19:01)

Ça peut être une notion d'angina répétition et quand il s'agit d'une cardiopathie congénitale, c'est-à-dire un rétrécissement mitral congénital, il faut poser les questions concernant le déroulement de la grossesse. Est-ce qu'il y a une notion de prise de médicaments? Est-ce que la maman prend des traitements particuliers? Est-ce qu'il y a une notion de consanguinité des parents? etc. La troisième étape, c'est de détailler le symptôme pour lequel le malade a consulté avec les autres signes associés.

Le malade sylvien spécialement pour la dyspnée peut avoir d'autres signes associés comme des palpitations, asthénie, un retard staturopondéral ou un amaigrissement. Après l'interrogatoire qui va comporter les caractéristiques des signes sémiologiques, les signes associés ainsi que les antécédents, on va passer à l'examen physique et on commence par l'inspection. Dans les formes historiques de rétrécissement mitral, on peut avoir ce qu'on appelle un faciès mitral ou bien le faciès de chatuc.

(19:02 - 20:13)

Il s'agit, comme vous le voyez sur la photo, d'une erythrocyanose des pommettes et des lèvres et ça traduit la présence d'une hypertension pulmonaire qui est importante. La palpation va concerner les foyers d'auscultation et du moment qu'on est dans le foyer mitral, dans le rétrécissement mitral, donc on va trouver un frémissement catère, c'est-à-dire qui ressemble au frémissement au rognement du chat et qui est palpé au niveau de la pointe du cœur et il est renforcé en décubitus latéral gauche. On arrive à l'auscultation dans le rétrécissement mitral qui va se traduire par trois éléments appelés le rythme mitral 2 du rosier.

Le premier élément c'est l'éclat de B1 au niveau de la pointe. Pourquoi? Parce qu'on sait que B1 correspond à la fermeture des valves auriculoventriculaire mitral et tricuspide. Donc quand la valve mitrale est malade, calcifiée, remaniée cette fermeture devient très audible et ça va nous donner un éclat de B1 au niveau de la pointe, c'est-à-dire au niveau du foyer mitral.

(20:13 - 22:06)

On aura aussi un claquement d'ouverture de la valve mitrale. Normalement l'ouverture de la valve mitrale n'est pas audible et elle coïncide un petit peu avec un petit décalage avec B2 qui correspond en général à la fermeture des valves osigmoïdes aortiques et pulmonaires. Donc quand cette ouverture de la valve devient audible, ça donne ce qu'on appelle le claquement d'ouverture de la valve mitrale qui est entendu juste après B2.

Enfin, on va trouver le roulement diastolique du rétrécissement mitral. Il faut noter que dans le rétrécissement mitral, on ne parle pas de souffle, c'est-à-dire qu'on ne dit pas souffle de rétrécissement mitral, mais on parle de roulement diastolique de rétrécissement mitral. Ce roulement a bien sûr ses caractéristiques.

Il siège au niveau de la pointe, il est diastolique, il débute immédiatement après le claquement d'ouverture de la valve et il a un renforcement pré-systolique. Son timbre est un type de roulement, c'est pour ça qu'on ne parle pas de souffle. Il n'irradie pas et il augmente à l'effort et en décubitus latéral gauche.

Il faut faire attention que dans le rétrécissement mitral serré, ce souffle peut être très atténué donc il faut être vraiment attentif pour l'ausculter et c'est que l'éclat de B1 avec le claquement d'ouverture de la valve mitrale qui permettent d'orienter le diagnostic et le souffle. A côté de cette triade de durosier, on va trouver des signes de complications, notamment l'hypertension pulmonaire, les signes d'insuffisance cardiaque gauche et les signes d'insuffisance cardiaque droite. On arrive aux examens paracliniques et on le sait très bien maintenant en cardiologie, les deux examens de première intention, c'est l'électrocardiogramme et la radiographie thoracique.

(22:06 - 23:32)

En ce qui concerne l'électrocardiogramme, on aura toutes les complications ou bien les retentissements qu'on a vu dans la physiopathologie, c'est à dire hypertrophie auriculaire gauche, hypertrophie auriculaire droite, hypertrophie ventriculaire droite et des troubles de rythme, notamment la fibrillation auriculaire. Bien évidemment, dans le RN pur, on ne va pas trouver d'hypertrophie ventriculaire gauche parce que comme on l'a vu dans la physiopathologie, il y a une diminution du remplissage du VG, donc il n'y a aucune raison pour qu'il soit dilaté s'il n'y a pas une autre étiologie qui l'explique. La radiographie thoracique, bien sûr dans les formes serrées, va montrer des signes en faveur d'une dilatation cavitaire comme l'allongement de l'arc moyen gauche ou un aspect en double bosse qui va être en rapport avec la dilatation de l'oreillette gauche et l'hypertension pulmonaire.

L'arc inférieur gauche, il va avoir une pointe SUS diaphragmatique en rapport avec une dilatation du ventricule droit. On peut avoir au niveau du côté droit, un arc inférieur droit qui est débordé, c'est à dire un débord droit ou bien un aspect en double contour qui va traduire la dilatation de l'oreillette droite et la dilatation de l'oreillette gauche. On peut trouver aussi un

syndrome interstitiel ou alvéolaire en rapport avec l'insuffisance cardiaque gauche ou le dème aigu des poumons.

(23:33 - 27:03)

On arrive maintenant à l'échocardiographie qui constitue l'examen clé au diagnostic du rétrécissement mitral car elle permet le diagnostic du positif du rétrécissement mitral de nous donner le diagnostic étiologique à travers l'étude de la morphologie et du mécanisme d'étudier la sévérité. L'échocardiographie va nous donner aussi des renseignements concernant le retentissement c'est à dire la dilatation de l'oreillette gauche, la présence d'un thrombus ou non la sévérité et la présence d'hypertension pulmonaire, la dilatation des cavités droites ainsi que leurs fonctions. Enfin, l'échocardiographie va nous donner une idée sur les autres atteintes associées comme valvulopathie dans le cadre des valvulopathies rhumatismales ou bien d'autres malformations congénitales quand on est face à un rétrécissement mitral congénital.

Enfin, le cathétérisme est comme pour les autres valvulopathies qu'on a vu précédemment il reste rarement nécessaire. On peut demander le cathétérisme droit pour mesurer les pressions pulmonaires mais l'indication reste vraiment limitée et l'indication principale du cathétérisme reste chez l'homme après l'âge de 40 ans et chez la femme après la ménopause quand l'indication opératoire a été posée et ceci pour étudier les artères coronaires comme ça s'il y a un geste à faire, on le fait en parallèle avec le remplacement valvulaire mitral. Qu'en est-il maintenant de l'évolution et des complications? Donc, on a deux types comme on l'a dit dans la physiopathologie.

Il y a des modalités évolutives et des complications qui sont liées à la valvulopathie et ça peut être une insuffisance cardiaque gauche au lieu d'aigu des poumons, une hypertension pulmonaire insuffisance cardiaque globale, un trouble de rythme comme la fibrillation auriculaire et des accidents thromboemboliques comme l'accident vasculaire ischémique et les ischémies aiguës des membres inférieurs ou autres. Bref, toutes les complications qu'on a vues dans la physiopathologie. Maintenant, il y a des complications non liées à la sévérité de la valvulopathie et il s'agit de l'endocardite infectieuse et comme on l'a dit le rétrécissement mitral reste très peu pourvoyeur d'endocardite infectieuse comparativement à l'insuffisance mitrale ou aortique, c'est-à-dire par rapport aux valvulopathies fuyantes.

On arrive maintenant aux formes cliniques qui sont en nombre de cinq. La première, c'est le rétrécissement mitral des matins, appelée la forme de Galavarda. C'est des femmes jeunes, en général qui ont une oreillette gauche peu dilatée, c'est-à-dire que l'oreillette gauche ne subit pas beaucoup de conséquences, donc ils transmettent directement la pression vers les poumons et donc c'est le poumon qui va souffrir et ces patients vont présenter plus d'œdèmes aigus des poumons.

Donc la deuxième forme, c'est la forme avec hypertension pulmonaire précapillaire. Il s'agit en général d'hommes ou de sexes masculins et ces patients vont faire plutôt de l'insuffisance cardiaque droite et pas d'œdèmes aigus du poumon, c'est-à-dire l'oreillette gauche va moins

souffrir, le poumon moins et c'est les cavités droites qui vont subir les conséquences. La troisième forme, c'est là où l'oreillette gauche va souffrir le plus.

(27:03 - 27:59)

Donc on trouvera une oreillette gauche qui est très dilatée, ces patients vont faire moins d'œdèmes aigus du poumon, moins d'insuffisance cardiaque parce que l'oreillette gauche va constituer une sorte de tampon. Mais ces patients vont faire beaucoup de troubles de rythme avec fibrillation auriculaire, des thrombus intra-auriculaire gauche et cette dilatation peut être monstrueuse jusqu'au point de donner des douleurs dorsales avec des dysphonies par compression du nerf récurrent. Et enfin, il y a la forme muée de découverte fortuite ou lors de complications.

Une dernière forme, c'est les formes associées. Le rétrécissement mitral est le plus souvent associé à une insuffisance aortique, parfois modérée, c'est une association très fréquente. RAO, rétrécissement aortique, reste rare.

(28:00 - 29:18)

Rétrécissement mitral plus insuffisance mitrale, on l'appelle maladie mitrale, c'est quand même fréquent. Et enfin, le rétrécissement mitral avec communication interauriculaire, appelé le syndrome de Luttenbacher. On arrive maintenant au traitement du rétrécissement mitral.

L'objectif du traitement, comme la plupart des pathologies, peut être curatif, étiologique, c'est-à-dire l'étiologie du rétrécissement mitral, ça peut être un traitement des complications de ce rétrécissement mitral et enfin, traitement préventif des maladies qui vont être responsables du rétrécissement mitral, notamment le traumatisme articulaire. Donc les moyens dont on dispose, d'abord le traitement médicamenteux, notamment les diurétiques, on peut avoir recours aux anticoagulants pour le traitement des thrombus ou pour prévenir l'apparition des thrombus, antiarythmique pour les troubles de rythme et puis le traitement antibiotique pour les infections. En ce qui concerne le traitement chirurgical, le traitement de base, c'est le remplacement du traitement valvulaire mitral, soit par une valve mécanique, une prothèse ou bien une prothèse biologique.

(29:19 - 30:51)

D'autres techniques chirurgicales comme la commissurotomie à cœur fermé, elle est presque abandonnée, on ne la voit plus, et la commissurotomie à cœur ouvert, on la voit maintenant de moins en moins, elle est réservée pour les rétrécissements mitraux modérés, quand il y a une autre indication, c'est-à-dire valvulopathie aortique ou autre et avec rétrécissement mitral qui est modéré ou peu serré, là on peut faire une commissurotomie à cœur ouvert. Mais le traitement de base, c'est le remplacement valvulaire prothétique soit par une valve mécanique, soit par une valve biologique. On peut avoir aussi recours au traitement interventionnel, c'est la dilatation mitrale percutane, c'est-à-dire on introduit un cathéter par voie fémorale qui va

monter jusqu'à l'oreillette droite, traverser le septum interauriculaire pour aboutir à la valve mitrale.

Une fois il est là, on va dégonfler un ballonnet qui va permettre d'éclater ou d'ouvrir les commissures et améliorer la surface mitrale. Les indications thérapeutiques, donc comme on l'a dit tout à l'heure, le traitement chirurgical ou interventionnel reste le traitement curatif des rétrécissements mitraux. Les indications du traitement, c'est quand on a un rétrécissement mitral symptomatique ou compliqué, d'insuffisance cardiaque droite, de fibrillation auriculaire ou d'hypertension pulmonaire.

(30:52 - 31:41)

Le choix entre les deux méthodes dépend de plusieurs critères. Vous n'êtes pas obligé, on ne vous demande pas de retenir ces critères, ça reste du domaine spécialisé mais d'une manière générale, le degré de l'épaississement, le raccourcissement de cordage, la présence d'une insuffisance mitrale, la présence d'autres valvulopathies. Tout ça, c'est des critères qui vont nous permettre de choisir soit le traitement interventionnel soit le traitement chirurgical.

On va voir maintenant le traitement des complications. Le traitement de l'insuffisance cardiaque, c'est à base de diurétiques. Il faut éviter les IUC dans les rétrécissements mitraux parce que c'est des vasodilatateurs, donc ils vont aggraver encore plus le retour veineux et ils vont aggraver le débit cardiaque par la suite.

(31:41 - 33:09)

Pour les troubles de rythme, on peut avoir recours à la digoxine ou au bêtabloquant associé aux traitements anticoagulants pour prévenir la constitution du thrombus. Quand on a un thrombus déjà constitué, il faut le traiter par les anticoagulants et le traitement de l'endocardite infectieuse ou la prévention de l'endocardite infectieuse qui se fait par les antibiotiques. On revient toujours au traitement préventif.

Comme on l'a dit, la prévention principale concerne la prévention de l'endocardite infectieuse et comme on l'a dit pour tous les cours d'évaluopathie, le rétrécissement mitral aussi est classé à risque faible d'endocardite infectieuse mais dans notre contexte et vu le nombre de patients qu'on voit avec endocardite infectieuse à porte d'entrée bucodentaire, surtout quand on a une insuffisance mitrale associée, donc l'antibioprophylaxie reste nécessaire à base d'amoxyciline 50 mg kilo une heure avant les soins dentaires ou bien 2 grammes pour l'adulte. La prévention bien sûr de RAA se fait par le traitement des angines à répétition, le traitement à chaque fois qu'il faut traiter les angines et puis l'extensiline chez les patients qui ont un antécédent de RAA. Voilà, on arrive à la fin du cours pour dire que le rétrécissement mitral reste une pathologie qui est fréquente.

(33:09 - 33:35)

L'étiologie principale, c'est le rhumatisme articulaire aigu. Les complications peuvent être

graves dans les formes serrées et ceci en l'absence du traitement. Le traitement curatif de base, il est soit chirurgical, soit interventionnel et on souligne l'intérêt de la prévention.

Vous trouvez dans les deux diapositives suivantes les abréviations utilisées dans ce cours. Je vous remercie.